

Fecha Última Actualización: 01-10-2022 8:07:35

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : José Daniel Arriagada Cabezas

Rut : 7.249.190-4

N° Archivo : A395268

N° Epicrisis

324990

Edad : 66a 10m 8d

Fecha Nacto: 23/11/1955

Sexo : Masculino

Dirección : Cerro Manantial 0369 Nosedal 1

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 950268512

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 28/09/2022 04:32

Días Estadía : 3

Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Egreso : 01/10/2022 08:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

DOLOR PERIANAL

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente hombre de 66 años

MC: Dolor Abdominal

ANTECEDENTES

Mórbidos: DM2IR

Medicamentos: Insulina

Alergias: (-)

Qx: Colectectomía y hernia inguinal antiguas, apendicectomía 2020, hemoperitoneo por trauma abdominal 05/2022

DIAGNOSTICOS DE INGRESO

1. Absceso perianal con drenaje espontáneo
2. DM2 mal controlada
3. Hipokalemia asintomática
4. Retención urinaria

HISTORIA ACTUAL

Consulta el 26/09 por historia de 4 días de dolor abdominal hipogástrico de evolución progresiva con mantención de tránsito intestinal y eliminación de gases. Diuresis conservada pero disminuida. Sin fiebre, náuseas y vómitos. Ingres a al SU en BCG, con abdomen distendido, resistencia muscular involuntaria, doloroso generalizado, Blumberg (+) difuso.

Se realiza evaluación con US y evidencia globo vesical y próstata aumentada de tamaño, se instala Foley y se drenan 900cc. Orina no inflamatoria. Exámenes GB 16500 80% NT, PCR 33, Crea 0,8, glicemia 340.

TAC abdomen sin patología quirúrgica.

El 27/09 re consulta esta vez por historia de 4 días de evolución de aumento de volumen en región perianal asociado a dolor que aumenta en defecación, y drena espontáneamente hoy saliendo líquido que refiere como claro. TAC informa Absceso perianal posterior central 4,8 x 2,8 x 3,5 que se extiende a la fosa isquiorrectal izquierda, probablemente en contexto de fístula perianal transesfinteriana. Se sugiere complementar con RM de pelvis para mayor caracterización. Cambios inflamatorios del mesenterio y peritoneo en la excavación pelviana de predominio anterior. No se observan colecciones abdominopelvianas.

Exámenes: Glucosa 317, PCR 71,7, Leuco 13,27, ELP 137/2,62/98.

Se hospitaliza para manejo.

Fecha Epicrisis : 01/10/2022 08:07

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:08

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 01-10-2022 8:07:35

Página 2 de 3

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

El 29/09 se ingresa a pabellón y se drena absceso sin complicaciones, no se identifica fístula perianal. Evolucionando favorablemente, se mantiene afebril, normocárdico, normotenso. Actualmente sin dolor en zona perianal, sólo prurito. Al EF se observan leves signos de grataje en zona glútea. Herida sana. Se recontrolan ELP, con K en rango. Se retira sonda foley y paciente presenta diuresis espontánea.

Diagnóstico de Egreso

ABSCESO ANORRECTAL -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable

Plan Post Alta

- Reposo relativo en domicilio. Mantenerse activo a tolerancia evitando reposo prolongado en cama.
- Régimen rico en fibra para lograr deposiciones blandas. Comer al menos tres porciones de frutas y verduras al día. Disminuir la ingesta de arroz, fideos, pan, zanahoria, quesos, manzana, chocolate.
- Hidratación con abundante agua (al menos dos litros al día).
- En caso de que con lo anterior no logre deposiciones blandas, puede usar (ELIGIR SOLO UNO)
 - ** 1. Vaselina líquida 10 cc (1 cucharada sopera) vía oral cada 8 a 12 horas, - ó -
 - ** 2. Polietilenglicol 17 gr vía oral cada 8 a 12 horas
- Ajustar toma según consistencia de deposiciones.
- No usar papel higiénico. Solo lavarse con agua tibia, con posterior secado con toalla de género (¿toques¿, sin movimiento de arrastre) o secador de pelo aire frío.
- Evitar el pujo: sentarse únicamente con deseo inminente de defecar. Permanecer sentado máximo 2-3 minutos.
- Baños de asiento con agua tibia-caliente por 5 minutos, al menos 3 veces al día. Región perianal debe sumergirse en el agua. Posterior secado según lo ya descrito.
- Puede usar apósito sobrepuesto en ropa interior según lo necesario para evitar manchas.
- Fármacos:
 - * Amoxicilina / Ácido clavulánico 875/125 mg: 1 comprimido cada 12 horas vía oral x 7 días
 - * Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 horas vía oral x 5-7 días
 - * Ketoprofeno 50 mg cada 8 horas vía oral S.O.S. en caso de persistir dolor. Máximo por 3 días
 - * Omeprazol 20 mg en la mañana vía oral x 7 días
 - * Mantener toma de resto de medicamentos habituales
- Control en Poli Becados Coloproctología en 2 semanas en CDT Pasillo 11. Será contactado vía telefónica para confirmar hora.
- Acudir a Servicio de Urgencias en caso de fiebre (temperatura axilar mayor o igual a 38°C), dolor abdominal intenso que no cede con analgesia, vómitos a repetición o según necesidad
- Ante dudas, contactarse a: ccontreras4@uc.cl

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Liviano

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 01/10/2022 08:07

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:08

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 01-10-2022 8:07:35

Página 3 de 3



Bec. Caterina Contreras Bertolo

Becado/Residente

INTERNO

Natalia Vega Rios

Médico Tratante (Staff)